

# Anafilaxia y angioedema — reconocimiento y manejo inmediato

*(Enfoque clínico aplicado a servicios de Urgencia y APS en Chile. Basado en consensos internacionales EAACI/WAO/AAAAI actualizados y lineamientos usados en docencia nacional; adaptado al nivel EUNACOM.)*

---

## 1) Introducción y relevancia clínica

La **anafilaxia** es una reacción de hipersensibilidad **grave, de inicio súbito y evolución potencialmente fatal**, mediada en la mayoría de los casos por **degranulación mastocitaria/basófila** con liberación masiva de mediadores (histamina, triptasa, leucotrienos). Su presentación es **multisistémica** (piel, vía aérea, respiratorio, cardiovascular y/o gastrointestinal) y **requiere tratamiento inmediato con adrenalina intramuscular**, sin esperar exámenes.

El **angioedema** es un **edema súbito y localizado de la dermis profunda/subcutáneo y mucosas**. Puede ser **histaminérgico** (alérgico, parte de la anafilaxia o aislado) o **bradicinérgico** (por déficit de C1 inhibidor o por IECA). Reconocer el mecanismo es vital porque **el angioedema por bradicinina no responde a antihistamínicos ni corticoides** y el **manejo se centra en la vía aérea** y terapias específicas (p. ej., **icatibant** o **concentrado de C1-INH** cuando estén disponibles).

**Importancia en EUNACOM y práctica:**

- Alta frecuencia en Urgencia y APS (alimentos, fármacos, picaduras, contraste).
  - El **diagnóstico es clínico** y la **adrenalina IM salva vidas**; los errores clásicos son **demorarla o sustituirla por antihistamínicos/corticoides**.
  - En Chile, el acceso rápido a adrenalina IM y la **observación adecuada por riesgo de anafilaxia bifásica** son estándares evaluados.
- 

## 2) Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1. Anafilaxia (histaminérgica)

- **Inmunológica (IgE mediada):** alérgeno se une a IgE en mastocitos/basófilos → degranulación inmediata. Ejemplos: **alimentos** (maní, frutos secos, mariscos, leche/huevo en niños), **fármacos** (betalactámicos, AINEs), **venenos de himenópteros, látex**.

- **No IgE (inmunológica o no inmunológica):** activación directa de mastocitos (opiáceos, medios de contraste, ejercicio, frío), o por **complemento**.
- Mediadores: histamina, triptasa, prostaglandinas, leucotrienos → **vasodilatación, aumento de permeabilidad** (edema), **broncoespasmo, urticaria/angioedema y hipotensión**.

## 2.2. Angioedema

- **Histaminérgico:** parte del espectro urticaria/anafilaxia; **pruriginoso** y con lesiones cutáneas superficiales asociadas. Responde a **antihistamínicos y corticoides**; si hay compromiso sistémico → manejo de anafilaxia.

- **Bradicinérgico:**

- **Hereditario (AEH) o adquirido** (déficit de C1-INH): exceso de **bradicinina** por falta de regulación del sistema de contacto/callicreína.
- **Inducido por IECA:** inhibición de degradación de bradicinina.

Características: **sin prurito, sin urticaria**, edema desfigurante (labios, lengua, glotis), posible **dolor abdominal por edema intestinal**. **No responde** a antihistamínicos ni corticoides; la adrenalina puede ayudar si hay vasodilatación/taquicardia concomitante, pero el eje del manejo es **vía aérea** y agentes específicos.

## 2.3. Factores de riesgo y escenarios típicos

- **Alimentos** (niños y jóvenes), **fármacos** (adultos y ancianos), **venenos de insectos, ejercicio dependiente de alimentos, anestesia** (látex, relajantes musculares, antibióticos), **contrastos**.
- Comorbilidades: **asma** (agrava hipoxemia), **mastocitosis, embarazo, uso de betabloqueadores** (pueden disminuir respuesta a adrenalina).

---

# 3) Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

## 3.1. Criterios clínicos de anafilaxia (resumen práctico)

Considere **anafilaxia** cuando, **de minutos a pocas horas** tras exposición probable, aparece cualquiera de los siguientes:

1. **Compromiso cutáneo-mucoso** (urticaria generalizada, prurito, eritema, angioedema de labios/lengua) + al menos uno:
  - Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia).
  - Compromiso cardiovascular (hipotensión, síncope, colapso).
  - Síntomas GI persistentes (dolor cólico, vómitos repetidos).
2. **Hipotensión** o colapso tras exposición conocida/probable a alérgeno, **aun sin piel**.

En lactantes: irritabilidad, hipotonía, cianosis, rechazo alimentario pueden ser equivalentes.

### 3.2. Manifestaciones por sistemas

- **Piel/mucosas:** urticaria, rubor, prurito, angioedema (labios, párpados, lengua).
- **Respiratorio:** congestión nasal, disfonía, tos, broncoespasmo, **estridor laríngeo**.
- **Cardiovascular:** **hipotensión**, taquicardia, shock.
- **Gastrointestinal:** náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.
- **Neurológico:** mareo, síncope.

### 3.3. Angioedema: claves clínicas

- **Histaminérgico:** edema + urticaria/prurito; suele coexistir con otras manifestaciones sistémicas si es anafilaxia.
- **Bradicinérgico (AEH, IECA):** edema desfigurante **sin urticaria ni prurito**, progreso más lento (horas), **dolor abdominal**; mayor riesgo de obstrucción de vía aérea.

### 3.4. Diagnóstico diferencial

- **Reacción vasovagal** (desencadenante procedimental): bradicardia, palidez, diaforesis, **sin urticaria ni broncoespasmo**; responde a posición supina y fluidos.
- **Crisis asmática aislada:** broncoespasmo sin urticaria/hipotensión.
- **Síncope cardiogénico, hipoglicemia, shock séptico.**
- **Edema no alérgico** (tiroidopatías, síndrome nefrótico), **angioedema bradicinérgico**.

---

## 4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La **anafilaxia** es un diagnóstico clínico y **no debe retrasarse la adrenalina** por exámenes.

Útiles (sin demorar tratamiento):

- **Tryptasa sérica** (pico a 1–2 h; tomar dentro de las 3 h del inicio y una basal a las 24–48 h). Elevada apoya degranulación mastocitaria (no siempre se eleva en anafilaxia por alimentos).
- **Laboratorio básico** si inestabilidad: hemograma, gases, lactato, electrolitos, creatinina.
- **ECG** en hipotensión/arritmias.
- **En angioedema recurrente sin urticaria: C4 disminuido y C1-INH** (nivel/función) para AEH o adquirido (estudio ambulatorio cuando el paciente esté estable).

---

## 5) Tratamiento (según guías de urgencia — enfoque chileno)

### 5.1. Principios

- **Adrenalina IM inmediata** en la cara anterolateral del muslo (no deltoides), **dosis 0,01 mg/kg** (máximo **0,5 mg** por dosis en adultos; **0,3 mg** niños >30 kg; **0,15 mg** en 15–30 kg). Repetir cada **5–15 minutos** si persiste compromiso.
- **Posición:** decúbito supino con piernas elevadas; embarazadas en **decúbito lateral izquierdo**.
- **Oxígeno alto flujo** (objetivo  $\text{SatO}_2 >94\%$ ).
- **Cristaloides EV** (20 ml/kg en bolo) si hipotensión/shock; repetir según respuesta.
- **Monitoreo:** PA, FC,  $\text{SatO}_2$  , ECG.
- **No espere antihistamínicos ni corticoides para decidir adrenalina.**

En **asma/broncoespasmo** marcado: **salbutamol** inhalado/nebulizado adicional; si estridor → maneje vía aérea precozmente.

## 5.2. Fármacos de apoyo (no sustituyen adrenalina)

- **Antihistamínicos H1** (cetirizina/loratadina VO o clorfenamina IV/IM) para **urticaria/prurito**.
- **Corticoides sistémicos** (p. ej., **metilprednisolona EV** o **prednisona VO**) pueden disminuir duración de urticaria/broncoespasmo tardío; **no previenen** de forma confiable la anafilaxia bifásica y **no son de primera línea**.
- **H2** (ranitidina/famotidina, si disponible) como coadyuvantes cutáneos.
- **β2 inhalado** (salbutamol) en broncoespasmo; **ipratropio** si respuesta parcial.
- **Glucagón EV** en pacientes bajo **betabloqueadores** con hipotensión refractaria a adrenalina (1–2 mg EV, luego infusión).
- **Vasopresores** (norepinefrina) si shock refractario pese a bolos de cristaloides y adrenalina repetida.

## 5.3. Vía aérea difícil / edema laríngeo

- **Señales de alarma:** estridor, disfonía, dificultad para tragar, sialorrea, tiraje, edema lingual.
- **Acción inmediata:** repetir **adrenalina IM**, **oxígeno**, preparar **intubación orotraqueal** por operador experto.
- **Nebulización con adrenalina racémica** puede aliviar estridor en espera de vía definitiva.
- **Cricotiroidotomía** si intubación imposible y obstrucción inminente.

## 5.4. Observación y alta

- **Observación mínima 4–6 h** en anafilaxia leve-moderada; **12–24 h** si fue grave, requirió múltiples dosis de adrenalina, hubo hipotensión, asma concomitante o distancia geográfica a atención.
- **Plan de alta:**
  - **Educación** sobre anafilaxia, **evitar desencadenante** y **leer etiquetas**.

- Prescribir **autoinyector de adrenalina** (si disponible) o **ampollas + jeringa** con instrucciones claras.
- Antihistamínico no sedante por 3–5 días si urticaria.
- Coordinar **derivación a alergología/inmunología** para estudio causal (alimentos, fármacos, venenos).
- **Plan escrito** de acción y **tarjeta de alergia**.

## 5.5. Embarazo

- **Adrenalina IM** es **segura y prioritaria**; mejora perfusión materno-fetal al revertir el shock. Posición en **lateral izquierdo**. Considerar **monitorización fetal** si viable.

## 5.6. Pediatría

- Dosis **0,01 mg/kg** (máx. 0,3 mg) **IM**; aerosoles y líquidos según peso. Signos sutiles: irritabilidad, hipotonía, vómitos incoercibles, urticaria generalizada, sibilancias.

---

# 6) Manejo del angioedema: particularidades

## 6.1. Histaminérgico (con o sin anafilaxia)

- **Si hay criterios de anafilaxia** → trate como anafilaxia (adrenalina IM, etc.).
- **Si es aislado y leve (sin vía aérea)**: antihistamínico no sedante; considerar corticoide VO corto; observación breve.
- **Recurrente con urticaria**: pensar en **urticaria crónica** (manejo con antihistamínicos a dosis altas; derivación si refractaria).

## 6.2. Bradicinérgico

- **IECA: suspender inmediatamente**; evitar también en el futuro. Manejo de vía aérea prioritario. **Icatibant** SC (si disponible) acelera resolución; adrenalina/antihistamínicos/corticoides **tienen poca o nula eficacia**.
- **Hereditario/adquirido por C1-INH**:

- En crisis aguda con vía aérea en riesgo: **C1-INH plasmático** (20 UI/kg) o **icatibant** (30 mg SC, repetir si persiste). Alternativas: **ecallantide** (no disponible ampliamente).
- **Evitar** estrógenos y IECA/ARA-II en AEH.
- Profilaxis a largo plazo (especialistas): **lanadelumab**, **berotralstat**, **C1-INH** subcutáneo, o **ácido tranexámico** cuando biológicos no disponibles.
- **Edema intestinal**: hidratación, analgesia; la administración de **C1-INH/icatibant** resuelve más rápido el dolor.

Cualquiera sea el mecanismo, **si hay lengua/laringe comprometidas** o progresión rápida, prepare **vía aérea** y **UCI**.

---

## 7) Complicaciones y pronóstico

- **Bifásica**: recurrencia de síntomas **4–24 h** (a veces hasta 72 h) tras aparente resolución; más común si presentación grave, hipotensión, múltiples dosis de adrenalina o retraso en la primera dosis.
- **Shock refractario, hipoxia, arritmias** (inusuales con IM; más riesgo con IV).
- **Broncoespasmo severo** en asmáticos.
- **Compromiso laríngeo** con necesidad de vía aérea quirúrgica.
- **En AEH**: mortalidad histórica por asfixia; hoy disminuye con **reconocimiento y terapias específicas**.

Con tratamiento correcto y precoz, el **pronóstico es excelente**. La mortalidad en anafilaxia se asocia a **retraso en adrenalina** y a **asma no controlada**. En angioedema bradicinérgico, el riesgo vital es **obstrucción de vía aérea**.

---

## 8) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### ☐ Perlas

1. **Adrenalina IM** en cara anterolateral del muslo es el **tratamiento de elección**; **no la retrase** por exámenes o por “esperar antihistamínicos”.

2. En **anafilaxia sin lesiones de piel** (p. ej., **hipotensión + broncoespasmo** tras antibiótico) **igual es anafilaxia** → adrenalina IM.
3. **Observación ≥4–6 h** (y 12–24 h si fue grave) por riesgo de **anafilaxia bifásica**.
4. **Angioedema sin urticaria + IECA/AEH** → piense en **bradicinina**: **antihistamínicos/corticoides no funcionan**; **priorice vía aérea** y considere **icatibant/C1-INH**.
5. **Glucagón EV** ayuda si el paciente usa **betabloqueadores** y no responde a adrenalina.
6. **Embarazo**: adrenalina **sí** se usa y es prioritaria; decúbito **lateral izquierdo**.

#### ☐ Errores frecuentes

- **Sustituir adrenalina** por clorfenamina/hidrocortisona.
- **Administrar IV** adrenalina en ambiente no monitorizado (riesgo de arritmias); en anafilaxia se prefiere **IM**.
- **Alta precoz** sin observación en cuadros moderados-graves.
- **No educar** ni prescribir **autoinyector** (o plan alternativo) en pacientes con riesgo de recurrencia.
- **No suspender IECA** ante angioedema.
- **Dudar en intubar** frente a edema lingual/laríngeo progresivo.

---

## 9) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **anafilaxia** es un diagnóstico **clínico** y una **emergencia vital**; el **primer y principal tratamiento es adrenalina IM (0,01 mg/kg; máx. 0,5 mg)**, repetible cada 5–15 min.
2. **No espere exámenes** para tratar y **no sustituya** la adrenalina por antihistamínicos o corticoides.
3. Observe al paciente **4–6 h** (o **12–24 h** si fue grave/múltiples dosis) por riesgo **bifásico**; plan de alta con **autoinyector** y **derivación** a alergología.

4. **Angioedema histaminérgico**: se maneja como parte del espectro alérgico; si hay criterios de anafilaxia, **adrenalina IM**.
5. **Angioedema bradikinérgico (AEH/IECA)**: sin urticaria, no responde a antihistamínicos/corticoides; **priorizar vía aérea** y usar **icatibant/C1-INH** cuando estén disponibles.
6. En **betabloqueados** refractarios, administre **glucagón EV**.
7. En **embarazo**, la **adrenalina** es **segura y prioritaria**; posición **lateral izquierda**.